

안이비 9주차

내이질환에 속하는 이명, 난청이 메인 질환 + 안면신경 마비도 중요

01 이개질환

이개질환 = 귓바퀴 질환

耳介奇形 이개기형

1) 선천적인 이개기형

- 일측성, 남자에서 더 흔히 발생
- 미용적인 면에서 지장을 초래

① 발육과잉: 大耳症, 副耳介症, 多耳症

② 발육장애: 無耳, 小耳症, 突出耳症, 耳瘻孔
- 대부분 難聽을 초래

③ 위치이상: 抵位耳症, 杯狀耳

→ 구조가 온전하지 못하기 때문에 난청이 동반됨 → 난청이 동반되기 전에 최대한 언어 교육을 해야함

2) 후천적인 이개기형

- 耳血腫, 耳介軟骨膜炎, 外傷, 凍傷, 火傷 등으로 인해 耳介의 피부와 연골이 섬유화 및 연골소실, 결절 등이 발생하여 이개기형이 초래됨
- ex) 권투선수의 꽃양배추 귀

선천성 이루관(=선천성 전이개누공, 전이개낭종)

- 이륵과 이주 사이의 이개 전상부에 작은 누공 형성
- 증상 : 약간의 국부 소양감, 불쾌감이 있고 재차 감염시 국부 붉은색 종창, 동통과 고름이 흐르고 반복발작. 분비물의 자극으로 누공 주위에 습진, 감염이 유발되어 화농. 때로 감염성 난청 동반.
- 함몰된 누공 속에 낭포 형성, 또는 편평상피로 피막된 누공로를 형성. 간헐적 또는 지속적으로 악취가 나는 분비물을 동반하기도 함
- 변증론치

1) 胎毒蘊積 : 유아, 五味消毒飲

2) 濕熱稽留 : 성인, 黃連解毒湯

3) 氣血不足 : 托裏消毒飲

→ 염증 관리만 하는 식으로 치료함

耳介 血腫 이개 혈종

★ 타박이나 마찰 등으로 이개혈종이 호발하는 부위는? (09,13)

- 傷耳症. 타박, 마찰 등으로 外耳 및 耳介 피부내에 혈액이 고임
- 주로 耳介의 三角窩에서 다발
- 연골막과 연골사이 혹은 피부와 연골막사이에 혈액이 삼출되어 血腫 발생. 혈종을 바로 제거하지 않으면 섬유질로 변성되어 이개 모양이 변하거나 연골이 괴사되기도 함
- 증상 : 부분적인 부종, 홍종, 반상출혈 및 이개통증 또는 이상감각 발생
- 흔히 권투, 씨름, 레슬링, 유도과 같은 운동을 하는 사람에서 다발
- 치료 : 復元活血湯 內服. 16G 바늘로 흡인 후 트리암시놀론 inj

→ 귓바퀴 내 혈종을 최대한 제거하는 방향으로

耳介 凍傷 이개 동상

- 耳介의 구조상 외부에 노출되어 있으면서 피부하 조직이나 지방조직이 없으므로 동상이 걸리기가 쉽고 또한 치유가 곤란하며 쉽게 재발

- 분류

- 1) 1도(홍반성) : 작열감, 소양감, 홍반
- 2) 2도(수포성) : 수포 형성
- 3) 3도(괴저성) : 耳介 전체 혹은 이륵이 괴저를 일으키며 기형을 남김

- 변증시치

- 1) 내복 : 當歸四逆湯, 人蔘養榮湯, 桂枝當歸湯加減, 補陽還五湯
- 2) 외용 : 如神散, 白斂散, 貝母, 陽和膏 등
- 3) 침구치료 : 紅斑이 경미하면 중앙에灸를 시행. 紫色腫脹, 鬱血된 부위는 三稜鍼으로 瀉血

- 동상의 치료

- ① 먼저 38~42도의 물을 적신 면거즈로 20분간 대어줌. 아울러 진통제, 항생제를 투여
- ② 너무 찬물이나 뜨거운 물, 열선을 대는 것은 피함
- ③ 동상으로 인한 수포는 저절로 흡수되기를 기다림
- ④ 괴사조직은 즉각 제거하지 말고 괴저부위가 확실할 때에 제거

- 화상

① 1도(홍반성): 홍종열통

② 2도(수포성): 1도증상 + 수포

③ 3도(괴저성): 괴사, 화농, 변형 등

→ 한의학적으로는 한사이기 때문에 따뜻한 약들이 사용됨

→ 수포가 생겼다고 다 제거하지는 말고, 최대한 수포에 손을 안대는 식으로 치료함

이개 연골막염

★ 이문웅, 이풍득, 이근득 양방병명, 증상 차이를 쓰시오. (03,06,09,10)

- 韓: 耳門癰, 耳癰

- 원인: 이개 주위 외상, 혈증, 동창, 이절, 중이염 수술합병증 등에서 Pseudomonas 감염으로 발생

- 원인 : 肝膽火熱, 風熱壅遏, 脾胃濕熱

- 증상: 돌발적으로 이개 표면에 홍종동통이 심해지면서 주위로 확대, 암적색을 띠며 연골과 연골막사이의 피부가 화농. 심하면 이개 연골이 융해, 소실.

- 변증론치

1) 초기 : 梔子清肝湯, 龍膽瀉肝湯

2) 농이 형성 : 四妙勇安湯

3) 농액이 흐르고 궤양, 미란 : 托裏消毒飲, 黃芪內托散

4) 외용 : 靑黛散, 紅升丹

- 치료 : 항생제 복용, 국소 도포 및 괴사조직 제거

→ 귀 질환은 허증은 신, 실증은 간담의 문제로 봄

→ 이개 연골막염은 습열의 범주

耳郭 假性囊腫 이곽 가성낭종

- 韓 : 耳殼痰包, 耳殼流痰

- 30~40대, 여자보다는 남자에서 다발. 일측성, 특히 舟狀窩, 三角窩 부위에서 호발

- 과거력상 耳廓 손상 또는 압박을 받음

- 증상 : 耳廓부위가 종창되면서 灼熱感, 癢痒感 동반. 통증은 없음. 국부가 두텁게 융기되거나 피부색 변화 없음. 경계가 명확하고 누르면 탄력감, 파동감이 있고 눌렀을 때 통증이 발생. 융기된 부위를 찌르면 담황색 액체가 흐름.

- 변증론치

1) 내복 : 導痰湯加減, 清氣化痰丸

2) 외치 : 국부 소독 후 魚腥草 液이나 丹蔘 주사액 주입. 30% 芒硝液을 국부에 습포

- 예방

1) 낭종이 커지지 않도록 주의

2) 감염, 화농되지 않도록 소독

이개 습진

★ 서의학적으로 이개, 비전정에 발생한 피부염 습진의 각각 한방 병명은? (09,11,13,18)

★ 선이창과 이란을 감별하시오. (04)

- 韓 : 旋耳瘡, 月蝕瘡, 割耳瘡, 月蝕疳瘡, 黃水瘡, 黃水疱 → 만성 아토피

- 원인: 외이도염의 화농액 또는 만성중이염의 분비물이 이개를 자극하여 발생

- 여름에 다발, 영유아에서 호발. 때로 접촉피부염, 아토피 피부염, 지루 피부염과 병발하기도 함

- 증상 : 이곽의 주위 혹은 耳內的 기욕이 紅潮, 癢痒, 경미한 부종이 있으면서 점차적으로 黃水가 흐르고 痂皮가 발생. 만성기에는 鱗屑, 脫屑, 龜裂 등이 발생

- 변증론치

1) 급성 ① 風濕熱毒: 消風散合草薢滲濕湯

② 肝膽濕熱 : 龍膽瀉肝湯

2) 만성 - 血虛化燥 - 四物消風飲, 蔘苓白朮散, 當歸飲子

→ 피부질환 1순위 처방이 바로 당귀음자

耳性 대상포진

★ 58세 여성이 10일 전부터 귀 주변과 귓바퀴, 안면부위까지 따끔거리다가 일주일 전에 그 부위가 발적되며 수포가 생겼다. 어제 수포가 궤파되어 황수와 미란까지 발생하여 내원하였다. 현훈, 홍혈고만, 맥현삭을 보인다. 한의학적 병명은? (18)

★ 58세 여성이 10일 전부터 귀 주변과 귓바퀴 안면부위까지 따끔거리다가 일주일 전에 그 부위가 발적되며 수포가 생겼다. 어제 수포가 궤파되어 황수와 미란까지 발생하여 내원하였을 때, 한의학적 병명은? (15)

- 韓 : 耳爛, 火丹, 蛇串瘡, 耳火丹瘡

- 원인: 대상포진 바이러스가 슬신경절 침범

- Ramsay-Hunt 증후군. 봄, 여름에 호발. 일측성

- 증상: 耳竅傍, 耳介部 주위와 鼻面 까지 발적, 소양, 수포가 발생. 동통이 심해지면서 궤

파하여 黃水가 흐르고 미란해지며 건조해져서 癬皮 형성. 난청, 현훈, 안면신경 마비, 기타 뇌신경 손상의 증상 동반 가능

- 변증론치

1) 내복 : 肝膽濕熱 - 龍膽瀉肝湯

2) 외용 : 초기(黃連膏, 如意金黃散, 三黃洗劑), 궤파된 후(柏石散)

- 치료 : 항바이러스제(Acyclovir), 부신피질 호르몬제. 필요시 해열진통제, 항생제 활용

→ 한방에서는 수포가 생기고 딱지가 생기는 시간을 줄여주는 식으로 치료함. 소독을 하고, 수포를 터트리고, 출혈을 유도하고, 따뜻한 빛을 쬌어서 딱지가 생기는 기간을 단축

→ 대상포진에 인경약을 가미해서 용담사간탕을 기본처방으로 매우 많이 사용함

耳風毒(耳門毒) 이풍독(이문독)

★ 이문옹, 이풍독, 이근독 양방병명, 증상 차이를 쓰시오. (03,06,09,10)

- 耳介部 주위의 임파선염 혹은 부종 및 결절

- 耳根毒, 發耳의 증상과 비슷하여 耳竅의 상하, 좌우에 발적, 종대, 동통이 나타나지만 耳根毒처럼 심하지는 않다.

- 원인 : 手少陽經의 風熱이 相搏되거나 熱毒에 의해 발생.

- 치료 : 耳根毒의 치료법을 활용. 발적, 종대된 부위를 鍼刺로 궤파하는 것은禁함.

→ 직접 침습은 하지 않음

耳門骨傷 이문골상

- 측두골 골절

- 교통사고, 외상 타격, 추락 등으로 발생

- Battle's sign : 측두골 골절시 유양돌기를 덮고 있는 피부에 멍이 드는 것

- 횡골절과 종골절로 구분

① 종골절: 측면에서 둔한 힘이 가해졌을 때 다발하며 고실혈종으로 전음성 난청 발생

② 횡골절: 수직방향으로 외력이 가해질 경우에 발생하고 출혈에 의해 내이가 장애를 받아 기능탈락이 생기며 안면신경이 침범되는 수가 많다.

02 외이 및 고막질환

급성 국한성 외이도염

- 韓 : 耳癰, 耳控傷

- pool 병. 하계, 청소년에서 다발. 1주 내외 치유

- 원인 : 수영후, 耳垢나 異物 제거시 손상, 감염 등으로 耳竅內에 濕熱, 風熱 혹은 邪毒이 蘊積하여 발생

- 증상 : 耳竅內에 癰腫이 생겨 耳內 홍종, 椒目처럼 돌기되며 심한 耳痛 발생. 耳竅를 압박하거나 견인하면 더욱 동통이 극렬해짐. 심해지면 癰腫에 黃白色의 膿點과 膿液 유출

- 특징 : 耳介가 우뚝 서거나 뒤에서 앞으로 당길 때 동통이 극심. 특히 이주를 누르거나 이개를 잡아 당길 때 심함

- 변증론치

1) 내복: 風熱邪毒(五味消毒飲), 火熱結聚(黃連解毒湯合仙方活命飲)

2) 외용: 초기(熱敷, 冰酒液, 酚甘油), 耳周가 紅腫(黃連膏, 金黃散)

→ 옹 저 창 절 중 절에 해당 / 크기 : 절<창

범발성 외이도염

- 외이도 骨部에 생기는 범발성 외이도염 → 고막 근처라고 생각하면 됨

→ 이절보다는 조금 더 심한 증상

- 韓 : 耳瘡

- 耳竅內에 일어나는 瘡瘍으로 耳癰보다 重한 증상

- 여름과 가을에 호발. 이개를 상후방으로 당길 때 통증 유발

- 증상 : 발열, 오한과 耳竅內에 소양, 홍종, 작열동통, 미란, 궤양이 발생하고 黃白色의 膿液이 흐르며 耳竅의 외부에 까지 紅腫, 疼痛이 발생. 발적은 골부가 심하고 종창은 연골부가 심하다. 인접 림프절 종창, 압통 발생

- 변증론치

1) 風濕熱毒 : 五味消毒飲

2) 肝膽濕熱 : 龍膽瀉肝湯

3) 血虛邪滯 : 四物消風飲

4) ★ 통치방 : 鼠粘子湯 ★ → 올해 강조하심

5) 외용 : 耳周의 腫脹이 비대해진 경우 金黃散

- 예방 관리

- 1) 외이도 감염 주의, 청결 유지
- 2) 외이도가 습해지지 않도록 주의, 汚水가 들어가지 않게 관리
- 3) 辛辣炙燂한 음식과 飲酒를 피함

이진균증

- 韓: 耳痒
- 원인균: Aspergillus 나 Candida 균에 의해 발생
- 주로 피부염, 점액성 혹은 농성 이루, 수염, 목욕 등으로 외이도가 습해 있을 때와 알레르기에서 발생
- 다양한 국소 혹은 경구 항생제로 치료받아온 만성 외이도염 환자에서 다발
- 항생제를 많이 투여하면 급성 염증반응은 잘 나타나지 않지만 면역력이 떨어져 진균이 발생할 수 있음
- 증상: 耳竅內에 참기 어려운 극심한 癢痒感을 동반하는 질환으로 때로 耳脹悶感, 경미한 耳痛, 流水 동반
- 때로 외이도 深部에 灰黃色 혹은 黑色의 膜이 보이고 이를 제거하면 경도의 紅腫, 糜爛, 소량의 출혈 발생
- 변증론치
- 1) 내복
 - ① 風熱濕毒, 風火痰濕 : 龍膽瀉肝湯, 玄蔘貝母湯
 - ② 血虛有熱, 血虛風燥 : 四物湯合六君子湯加減
 - ③ 肝腎陰虛, 虛火上炎 : 六味地黃丸, 一貫煎加味
- 2) 외용 : 黃連 煎湯液으로 세척
- 이경으로 살펴보았을 때 외이도가 깨끗해보이지만 환자가 가려움을 호소하면 면봉에 오일을 찍어서 발라주면 알레르기 반응이 줄어들 수 있음

악성 외이도염

- 惡性으로 보이는 괴사성 외이도염(주로 녹농균)
- 녹농균은 항생제 반응도 잘 안보이고 골치아픈 균
- 韓: 耳聾
- 고령의 당뇨병 환자에서 다발
- 외이도에서 시작된 감염이 봉와직염, 연골염, 골염, 더 나아가 두개저 골수염까지 유발
- 병세가 매우 급하고 지속적이고 극렬한 耳痛이 특징

- 증상 : 극렬한 耳痛과 함께 외이도에서 농액이 흐르고 심하면 全身腫脹 유발. 외이도에 肉芽腫이 형성되기도 하고, 심하면 고막천공 동반. 뇌막염이나 뇌종양등 합병증으로 사망할 수도 있음

변증론치

- 1) 초기: 黃連解毒湯加減
- 2) 熱入營血 : 清營湯加減
- 3) 氣血兩虛시 生脈散 兼服
- 4) 口眼喎斜시 牽正散 兼服

이구전색

★ 54세 남자가 아침에 목욕을 한 이후에 갑작스러운 난청을 호소하며 내원하였다. 환자의 귀 안에는 귀지가 가득 차있는 소견을 보였다고 할 때, 이 환자에게 적절한 한의학적 진단명은 무엇인가? (10,19)

- 韓: 聾耳
- 귀지가 耳竅內에서 덩어리로 응결되어 耳竅가 폐색되는 증상 → 귀지와 관련
- 증상 : 이물감, 경미한 耳鳴과 심할 경우에는 難聽, 頭痛, 自聲強聽, 咳嗽발작 등이 유발
- 변증론치
- 1) 風熱 : 柴胡聰耳湯
- 2) 風溫 : 馬勃散
- 3) 肝膽濕熱 : 龍膽瀉肝湯, 柴胡清肝湯
- 4) 陰虛火旺 : 六味地黃湯
- 치료 : 이검자로 제거하거나 흡인, 이구 용해제 활용

이구

- 외이도 연골부의 이구선, 피지선, 한선 등에서 이지가 분비되고 표피의 각질, 먼지 등과 혼합되어 이구 형성
- 서양인은 습한 이구가, 동양인은 건조한 이구가 형성
- 기능 : 악산성. 항균, 항염증 및 피부를 외상에서 보호
- 특히 수영, 목욕 후 갑자기 난청을 호소하는 경우가 많은데, 이는 외이도에 물이 들어가 귀지가 불어나 외이도를 완전히 막아버리기 때문에

외이도 종양

1) 양성종양(耳痔)

- 외이도 골종, 외골증, 과골증 포함
- 耳竅 內에 小肉, 疣贅, 峙樣 등이 형성되어 耳脹痛, 耳痒, 耳鳴, 耳聾 등이 발생
- 종류: 혈관종, 낭종, 전이개누공, 켈로이드, 폐쇄성 각화증, 뼈돌출증과 골종, 선종 등

2) 악성종양(耳疔, 黑疔)

- 양성종양 + 통증이 심하고 출혈을 동반

외골증(外骨症; exostosis)

- 고막근처 혹은 추골돌기에 실질성 혹은 해면상의 골조직이 국한성으로 1개 혹은 2~3개의 황백색 구상 융기로 발생

과골증(過骨症; hyperostosis)

- 연골부와 골부의 접합부에 호발

외이도암

- 만성 화농성 중이염과 유사한 증상을 보임
- 혈성이루, 이통, 편두통, 외이도종창, 난청, 이명 등이 서서히 진행됨

양성종양(耳痔)

★ 이치(耳痔)와 이정(耳定)을 감별하시오. (04)

- 이개나 외이도에 발생하는 양성 종양(외이도골종, 外骨症, 過骨症), 耳息肉
- 증상 : 돌연히 耳竅內에 小肉, 疣贅 등과 함께 耳脹痛, 耳痒, 耳鳴, 耳聾이 발생, 甚해지면 疼痛이 극렬하여 腦顱에 까지 파급되며 出血과 때때로 膿水유출
- 외골종 및 과골종의 경우 골증식으로 외이도를 폐쇄하거나 거기에 이구가 차 있으면 난청, 이명, 이내압박감 등이 나타나고 중이염을 합병하였을 때에는 농즙의 배설을 방해
- 形態에 따라
 - ① 耳痔 - 櫻桃狀 혹은 羊奶狀
 - ② 耳蕈(耳菌) - 蕈菇狀 혹은 菌狀으로 頭大蒂小함
 - ③ 耳挺- 棗核狀, 細條而長하여 耳外로 노출됨
- 변증론치
 - ① 肝膽濕熱, 肝經怒火 - 梔子清肝湯, 丹梔逍遙散加減

② 腎經虛火 - 知柏八味丸, 六味地黃丸加減

③ 脾胃蘊熱 - 清胃散加減

- 치료: 외골증 또는 과골증의 경우 골증식이 커서 난청 등의 증상을 유발하면 외과적인 처치를 시행

<耳定(耳中生核)>

- 외이도골종, 外骨症, 過骨症
- 耳竅內에 小核 발생되어 梅子大로 커지고 때로는 동통이 나타남
- 감별 : 耳痔와 비슷하나, 耳痔에 비해 疼痛이 극렬하지 않고 또 뺨이나 腦部에 까지 파급되지 않으면서 小核의 상태로 유지되며, 潰파되거나 血水가 흐르는 증상을 보이지 않음
- 변증론치: 肝膽火熱熾盛 - 柴胡清肝散, 龍膽瀉肝湯

악성종양(耳疔, 黑疔)

- 이개 및 외이도의 악성종양인 癌, 肉腫과 감염으로 인한 이개 주위 **봉와직염**
- 증상 : 耳廓 혹은 耳竅內에 疔瘡가 나타나는데, 瘡根이 깊고 黑色의 川椒目이 堅硬하게 발생. 潰爛되면서 疼痛이 극렬하여 頰部 및 腦部에까지 파급되며 때로는 潰파되어 血水유출
- 변증론치 : 腎經 火毒이나 飲食, 丹石, 熱藥 등의 과도한 섭취로 발생 - 蟾酥丸, 黃連解毒湯, 五味消毒飲 등과 같은 疔瘡의 治療藥을 활용

耳內異物 이내이물

- 외이도내 이물
- 韓 : 白蟲入耳, 飛蛾入耳, 蚰蜒入耳, 耳中有物
- 耳竅內에 이물이나 蟲이 들어가 이통, 폐색감, 이물감과 耳鳴, 耳聾 등이 발생. 유생물의 경우 외이도내에서 운동을 하기 때문에 심한 동통과 잡음으로 고통을 많이 호소
- 치료 : 알코올로 탈수 수축 또는 유생물 사멸 후 검자로 제거

鼓膜炎(myringitis) 고막염

- 외상, 한랭, 외이도 이물에 의한 기계적인 자극, 외이도 및 중이 염증에서 나타나는 분비물이나 약물에 의한 자극, 감기, 결핵과 같은 혈행성 감염, Allergy로 인해 발생
- 다른 복합증상 없이 순수하게 이통을 호소하는 것은 급성 고막염의 특징이며 심한 경우 고막에 수포 형성

- 증상 : 患耳에 동통, 가벼운 이명, 중청감 발생. 고막의 색은 紅色 또는 淡紅色이며, 고막 상부에 더욱 현저하게 발생
- 변증론치
 - 1) 초기 : 風熱客襲(五味消毒飲)
 - 2) 病重 : 肝膽蘊熱(梔子清肝湯)
 - 3) 외용 : 黃連液, 耳炎靈 점적
- 조리에방 : 외이도와 고막의 표면을 청결하게 하여 이차적인 감염을 방지, 中耳炎으로 이행될 가능성이 많으므로 주의

여기서부터 내용은 참고 내용

<鼓膜損傷>

- 고막의 손상은 傷耳, 耳衄과 耳聾의 일종인 竅閉에서 발생하는 症狀
- 분류: 直達性(귀이개), 介達性(기압, 두개골 외상)
- 직접 찢려서 손상된게 직달성, 공기의 압력에 의해 손상된게 개달성
- 원인 및 치료
 - ① 耳衄(고막의 손상, 출혈성 고막염, 급성 화농성 중이염, 만성 중이염, 중이의 악성종양 등의 出血) : 外傷, 肝火上逆 氣血凝滯, 陰虛火旺 - 知柏地黃丸加味, 犀角地黃湯加味
 - ② 竅閉 : 손상 혹은 挫傷 또는 雷炮震傷 - 開通法으로 치료하되 峻攻하지 말고 점차적으로 調理
- 감별 : 炎症에 의한 고막천공과 外傷에 의한 천공은 서로 다르다.
 - ① 염증성 천공 : 변연이 평활, 凝血塊 무, 원형 또는 타원형, 농 분비물 유, 고막흔락, 청력감퇴 분명
 - ② 외상성 천공 : 변연이 예리, 凝血塊 유, 세장형, 반월형, 삼각형 등 裂孔狀, 농 분비물 무, 고막 정상, 청력감퇴 경미

<耳脹>

- 급만성 중이질환, 봉와직염, 유양돌기염
- 耳竅內에 脹悶, 폐색감과 耳脹痛이 나타나는 것, 오래되면 물체가 阻隔된 것과 같은 耳閉가 발생.
- 耳脹이 耳鳴 및 重聽과 겸하여 발생되면 耳聾의 초기 증상
- 변증론치 : 肝膽火熱 - 柴胡清肝散, 龍膽瀉肝湯 등

<耳痛>

- 원인 : ① 風熱, 風寒, 風濕熱邪의 侵入과 肝腎虧損으로 虛火가 上衝되어
 - ② 膽, 三焦經의 風熱上攻, 肝膽熱毒의 上蒸으로
 - ③ 氣滯血瘀
 - ④ 耳竅內에 蟲이 있어서도 發生
- 치료
 - ① 風熱痛 : 風熱表證 - 荊芥連翹湯, 蔘蘇飲.
 - ② 風寒痛 : 九味羌活湯, 羌防湯.
 - ③ 風濕熱痛 : 膿이 유출되면서 牙床까지 脹大 - 加味涼膈散
 - ④ 虛火痛 : 耳痛이 齒齦까지 파급되면서 腫大 - 雙和湯, 六味地黃丸, 八味地黃丸.
 - ⑤ 氣滯血瘀로 인한 耳痛 : 丹梔逍遙散, 清心蓮子飲, 龍膽瀉肝湯合四物湯
 - ⑥ 肝膽熱毒이 上蒸하여 疼痛이 甚하고 紅腫 - 龍膽瀉肝湯
- 다른 복합증상 없이 순수하게 이통을 호소하는 경우 급성 고막염을 의심. 심한 경우 수포를 형성. 천공은 없음

03 중이질환

중이염

- 중이강내 감염 및 염증으로 인한 음압 형성과 이로 인해 유발되는 삼출액의 분비 항진 및 저류로 발생
- 생후 6개월이 지나면서 발병률이 급격히 증가하여 3세경까지 약 70%의 유소아가 적어도 한 번 이상 이환
- 韓 : 膿耳
- 항생제의 발달 이후에 중이염의 급성 합병증, 특히 두개강 내의 감염 등은 많이 감소하였으나, 중이강내 저류액의 잔류나 유착으로 인한 청력장애 등의 만성 합병증은 오히려 증가

★ 유소아에서 성인에 비해 중이염이 쉽게 이환되는 이유 4가지를 쓰시오. (15,18)

★ 유소아에서 다발하는 이유 ★ → 올해 강조하심

- 1) 이관이 성인에 비해 상대적으로 더 넓고 짧으며 수평에 가까워 이관을 통해 역류 감염되기 쉬움
- 2) 이관 개폐에 관여하는 이관연골이나 연구개의 긴장, 이완 작용을 하는 근육 발달이 미숙
- 3) 성인에 비해 감염에 대한 면역기능이 미숙
- 4) 비인강에 림프조직이 많아 상기도 감염시 부종에 의해 이관 폐쇄가 빈번히 발생(아데노이드 증식증)하여 중이에 쉽게 영향

1) 급성 중이염 : 급성 화농성 중이염(세균성, 바이러스성, 괴저성)

- 염증의 초기 3주까지로, 발열, 동통, 고막의 발적, 삼출액 등의 증상이 유발되는 급성 화농성 중이염
- 韓 : 急膿耳, 膿耳, 聾耳
- 원인: 이관(감기, 상기도감염), 외이도(천공시 목욕, 수영 후), 혈행성(결핵)
- 발적기, 삼출기, 화농기, 용해기, 흡수기, 합병증기로 구분
- 증상: 박동성 동통, 38~40도의 고열(천공후 감소), 저음성 박동성 이명, 전음성 난청(귀머거리리에 가까울 정도의 심한 난청), 장액혈성 이루, 가장 먼저 이완부에 발적, 종창, 팽윤 발생 후 고막 전체 충혈 부종, 화농되면서 고막 전후 하방에 천공. 이외 자성강청, 두통, 현훈 등

- 변증론치

- 1) 風熱壅阻 : 오미소독음합연교산, 仙方活命飲
- 2) 肝膽濕熱 : 용담사간탕
- 3) 외용 : 鼓膜 未穿孔(氷酒液), 鼓膜 穿孔(耳炎靈, 黃連液)

급성 화농성 중이염의 단계

★ 급성 중이염의 단계에서 농성 점액농성 삼출물이 나오고 이통과 발열이 심한 단계는? (14,16)

★ 급성 중이염에서 고막 자연천공, 농성 이루, 발열 이통 감소, 전음성 난청은 더 심해지는 단계는? (08,11,12,13,18)

- 1기(발적기): 고막 발적, 광추 소실, 장액성 삼출물
- ★ 2기(삼출기): 농성, 점액농성 삼출물, 이통(자통) 발열 심
- ★ 3기(화농기): 고막 자연천공, 농성 이루(처음 회적색에서 점차 점액농성, 농성으로 진해짐), 발열 이통 감소, 전음성 난청은 더 심해짐
- 화농기가 되면 오히려 삼출물이 빠져나오면서 발열, 이통은 감소함
- 삼출기, 화농기의 개념 잘 알아두기. 올해 강조하심
- 4기(용해기): 육아조직 농 축적, 골미란, 심한 난청
- 5기(합병증기): 세균 염증이 유양돌기 밖으로 전파. 두개외 합병증(급성 유양돌기염, 안면 신경마비, 미로염 등), 두개내 합병증(뇌수막염, 두개내 농양, 소뇌농양, 횡정맥동 혈전증 등) 발생

2) 삼출성 중이염

★ 삼출성 중이염에 대하여 설명하시오. (04)

★ Case 문제 (02)

- 비세균성이나 알레르기로 인한 경미한 염증상태로 장액성, 분비성, 비화농성, 카타르성 중이염. 최근 항생제의 남용으로 증가추세
- 중이강내 삼출액 저류의 평균 지속기간은 23~40일로, 급성 중이염 환아의 2/3에서 삼출성 중이염이 속발
- 이관의 기능장애나 협착으로 음압상태가 되어 발생
- 고막은 광택이 없으며 추골병 후상부에 가벼운 발적 또는 방사상의 혈관노장을 보이고 보통 내함됨. 저류액이 생기면 고막이 엷어 보이고 황갈색, 이관통기로 수포성 잡음(물방울 터지는 소리) 청취

- 폐색감, 두위변화 연하 혹은 하품에 따른 액체가 움직이는 감각의 이명, 경도 내지 중등도의 전음성 난청. 이외 자성강청

<조기에 수술을 해야 하는 경우>

1. 양측성 병변
2. 양측성 난청
3. 언어발달 지연
4. 행동장애
5. 고막의 구조적 변화
6. 항생제 알레르기
7. 급성 중이염이 재발할 위험성이 높을 때

3) 만성 중이염(慢膿耳, 膿耳, 耳疳, 耳濕, 聾耳)

- 중이 및 유양봉소내의 지속적인 만성 염증상태로, 만성 화농성 중이염, 만성 삼출성 중이염과 진주종, 장액성 유양돌기염으로 분류
- 계속되는 난청, 고막천공과 지속적인 장액성 이루가 나타남
- 주로 농성 혹은 점액농성 耳漏와 전음성 난청이 발생
- 만성 중이염에서 천공성 71.7%, 진주종성 22.8% 의 유병률
- 임상 경과와 예후에 따라

1. 양성 중이염(중고실염; 단순 화농성 중이염) : 점액농성 분비물, 청력장애를 호소. 고막의 긴장부, 중심성 천공. 합병증 없이 수 년 또는 수십 년 이환

→ 양성 중이염이 가장 흔한 형태

2. 악성 중이염(상고실염; 진주종, 육아, 폴립 등) : 다른 정도의 난청, 두통, 역한 냄새의 분비물을 호소. 간혹 농혈. 고실에서 진주종 발견 가능
- 변증론치

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) 濕熱蘊結 : 비해삼습탕, 서점자탕 | 2) 脾虛濕困 : 탁리소독산 |
| 3) 脾腎陽虛 : 온신건비탕 | 4) 腎陰虧虛 : 지백지황탕 |

급성 vs 만성

1. 급성(急耳痺, 耳脹痛)

- 주로 감기와 동반. 겨울과 봄에 다발
- 전음성 난청(난청 정도는 약(20~30dB)하며 말을 듣는데 크게 지장 없음), 이명, 귀가 멍멍하고 막히는 듯한 느낌, 자성강청
- 고막 내함, 광택 소실되어 淡紅色, 고막연 혈관의 방사상 충혈, 淡黃色的 액체면이 두위에 따라 변화
- 변증론치: 風熱濕滯(은교산가감, 소풍청열탕), 膽經鬱熱(小柴胡湯合通氣散), 肝膽濕熱(용담사간탕가감)
- 중이강내 삼출액 저류가 6주 이내이고 급성 염증 소견이 없는 경우 1~2주까지 추적관찰(삼출액의 60%-1개월내, 80%-2개월내, 90%-3개월내 자연 완해)

2. 만성(耳痺, 耳脹閉, 耳閉)

- 중이강내 삼출액이 3개월 이상 지속되는 경우
- 주로 급성 비화농성 중이염의 병력. 계절과 무관
- 이폐색감, 청력 점차 감퇴, 자성강청, 저음성 이명
- 고막 내함, 혼탁, 비후하며 暗淡, 灰白色. 고막은 점액성 액체로 淡黃色
- 이관통기시 공기가 잘 들어가지 않거나 약간 들어감
- 진단: 이관통기검사시 고막 위치가 변동되거나 청력이 약간 호전되면 확진
- 변증론치: 邪滯血瘀 (通竅湯合通氣散), 脾虛濕困(보중익기탕, 金匱腎氣丸)

→ 급성은 습열의 범주 / 만성은 습의 범주

4) 中耳眞珠腫(cholesteatoma) 중이진주종

- 만성 중이염에서 중이내에 생기는 회백색의 광택을 가진 종양성 물질
- 결체조직성의 피낭으로 싸여 있으며 내부에는 각질로 변한 편평상피가 층만되어 있고 콜레스테롤을 함유. 진주종 자체가 주위 골벽에 압박을 주어 골의 궤양, 궤저유발
- 진성(중이염과 관계없이 두개저의 종양)과 가성(중이질환과 관련)으로 구분

5) 急性 壞疽性 中耳炎 급성 괴저성 중이염

6) 結核性 中耳炎 결핵성 중이염

7) 粘液球菌性 中耳炎 점액구균성 중이염

중이염의 후유증

1. 유착성 중이염 - 삼출성 중이염의 후유증. 고막이 위축되어 탄성을 소실하고 고막이 내함되어 나타나는데 후상방에서 많이 발생
2. 고실경화증 - 만성 염증의 후유증 또는 외상의 결과. 고막의 고유층과 중이 기저막에 유리질 변성이 일어나고 칼슘과 인 결정체가 축적되어 발생. 난청이 주증상. 대개 침착물이 반점이나 반달모양을 띠며(고막경화증)

중이염의 합병증

1. 안면신경마비 - 안면신경관의 뼈가 가장 얇은 슬상신경절과 고삭신경 분지부 사이에서 다발. 혀 반쪽의 미각장애와 편측 말초성 신경마비가 발생
2. 유양돌기염 - 급성 화농성 중이염의 가장 흔한 합병증. 항생제 사용으로 최근 많이 감소. 중이염 합병증으로 발생하는 경우 급성 중이염 치료 과정에서 다양한 약물을 투여하게 되므로 급성 유양돌기염에 비해 증상이 경미함
3. 화농성 뇌막염 - 주로 5세 이하의 소아에서 인플루엔자의 혈행성 감염으로 발생. 화농성 뇌막염의 약 1/3에서 후유증으로 행동장애, 지능저하, 농 등의 장애 발생

고막 천공

★ 고막 천공을 이관부, 중고실, 상고실 천공으로 구분하여 설명하시오. (04,09,15,19)

★ 25세 여자환자가 만성 중이염을 주소로 내원하였다. 이경으로 보니 고막 긴장부 후상방에 변연성천공이 관찰되었다. 천공의 양상은? (06,11)

- 고막 천공의 위치와 크기가 예후와 치료에 있어서 매우 중요.

- ① 중심성 천공 : 주로 粘膜 化膿을 의미
- ② 변연성 천공 : 骨化膿, 외이도로 부터 上皮의 침입과 동시에 진주종 형성의 가능성을 의미
- ③ 고막의 천공연이 赤色을 띠면 膿의 배설에 따르는 자극에 의한 것이고,
- ④ 천공연이 白色을 보이면 上皮의 침입을 의미
- ⑤ 이관부의 천공 : 고막의 전하방에 천공, 묶은 점액농성 이루, 鼻 및 鼻咽腔의 병변에서 자주 이환됨
- ⑥ 중고실의 천공 : 주로 고실의 병변, 천공은 중심성으로 비교적 크며, 점액농성이나 농성 이루
- ⑦ 상고실의 천공 : 고막 긴장부의 후상방에 변연성 천공이나 이관부의 천공, 상고실의 병변, 이루에서 악취가 나며 진주종 형성 가능성

膿耳

- 중이강에 발생하는 여러 가지 염증질환
- 耳膜이 꺾파되고 耳竅 內에서 膿液이 항시 혹은 간헐적으로 유출되는 질환

1) 급성

- 主로 實證
- 風熱表證의 전신증상 ④ 극렬한 耳痛, 耳根 주위 紅腫, 耳膜 천공
- 점조한 黃色, 靑綠色 또는 혈액이 섞인 紅色의 膿液, 혹은 惡臭
- 耳鳴과 耳聾이 兼
- 清熱瀉火

2) 만성

- 主로 虛證
- 腎虛와 脾虛로 인한 전신증상 ④ 耳膜 꺾파
- 清稀, 白稀色 혹은 黑色의 膿液이 時流時止하거나 또는 豆腐渣樣의 汚穢한 분비물이 계속적으로 흐르면서 惡臭
- 耳痛과 耳根 주위의 紅腫은 甚하지 않고, 천공된 耳膜의 瘡口가 수렴되지 않으며 耳鳴과 耳聾이 진행되어 障礙가 일어남
- 培補正氣

- 膿耳의 분류 <瘍醫准繩>

- ① 耳疳 : 黑膿, 惡臭, ② 震耳 : 虛鳴과 清膿, ③ 纏耳 : 白膿,
- ④ 聾耳 : 耳內가 核狀으로 폐색되면서 黃膿, 오래되면 耳聾 발생, ⑤ 耳濕 : 黃膿,
- ⑥ 風耳 혹은 耳風毒 : 紅膿.

- 변증론치

1) 급성

- 風熱, 濕熱과 肝經血熱, 肝膽火盛, 脾胃濕熱. 이외 小兒胎熱, 麻疹이나 傷寒病 後에 餘毒이 上衝
- 초기에는 銀翹散加減, 防風通聖散을, 耳內가 化膿腫痛, 生瘡되고 膿汁이 流出되면 柴胡清肝湯, 荊芥連翹湯, 龍膽瀉肝湯 등을, 肝膽熱毒의 熾盛으로 化膿腫痛이 甚하면 龍膽瀉肝湯加減을 사용.
- 外治 : 明礬散, 黃連液, 黃柏煎湯液

2) 만성 :

- 급성 농이에서 熱毒이 未清되어, 脾胃虛弱, 腎精虧損 虛火上炎, 腎經의 風熱上壅
- 일반적으로 蔓荊子散, 知柏地黃湯加減을, 오랫동안 膿耳가 진행되어 清稀, 白稀色 혹은 黑色의 膿液이 時流時止하거나 또는 塊狀 혹은 豆腐渣樣의 汚穢한 분비물이 계속적으로 흐르면 六味地黃丸加減, 知柏八味丸加減을, 耳膜의 穿孔된 瘡口가 融合되지 않고 稀薄한 膿液이 계속적으로 유출되면 托裏消毒散, 黃芪內托散을 사용.
- 이외에 太陰人에서는 葛根解肌湯, 防風通聖散을, 少陽人은 荊防地黃湯, 涼膈散火湯, 涼膈散을, 少陰人은 補中益氣湯, 香附子八物湯, 四物君子湯을 복용.

이관기능부전

- 이관의 기능

- 1) 환기기능(ventilation): 중이강과 대기의 압력이 같도록 조절
- 2) 배출기능(drainage): 유양동과 중이강 점막에서 분비되는 분비물을 비인강으로 배출
- 3) 방어기능(protection): 이관을 통해 역류하는 오염을 방지

- 이관기능부전의 종류 : 개방성 이관, 이관협착증 → 개방, 협착 두가지가 있음. 구분하기

→ 개방성 : 항상 열려있기 때문에 바람소리 같은 소리가 들림

→ 협착성 : 막혀있어서 공기가 안통하기 때문에 귀가 먹먹하고 이런 증상들이 심해짐

- 증상 : 이내 창만감, 폐색감, 자성강청, 자기의 호흡소리 인지, 바람소리와 같은 이명이 호흡과 일치하여 들림. 반듯이 눕거나 머리를 아래로 하면 잠시 증상이 줄어들거나 소실

- 이경 검사시 고막이 호흡에 따라 움직임을 볼 수 있음

- 변증론치

- 1) 肺失宣降 : 麻杏石甘湯
- 2) 脾虛清陷 : 補中益氣湯
- 3) 肝鬱氣滯 : 柴胡疏肝散

- 조리에방

- 1) 체질을 개선하며, 전신 만성질환을 근본적으로 치료
- 2) 너무 세게 코를 풀어서 콧물이 귀로 들어가는 것을 방지
- 3) 마음가짐을 편안하게 유지
- 4) 귀가 막히거나 이명이 심한 경우 누워있거나 머리를 아래로 하는 자세를 취함

유양돌기염

★ 39세 남자 환자로 2주 전에 39도씨 고열과 함께 좌측 귀가 매우 아프면서 종창감이 있더니 진물이 나오기 시작하면서 ~ X-선 소견상 함기세포가 혼탁되어 있었다. 의심되는 (1) 한의학적 질환 (2) 서양의학적 질환은? (08,12,14)

- 韓 : 耳根毒, 耳根癰

- 원인: 급성 중이염의 2차 합병증

- 증상: 고열(초기 37.5~40도), 통증(통증이 격감되었다가 다시 심한 이통), 농양(염증이 유양동에서 아래로 하행하여 골벽을 뚫고 외부로 파급 이개 하부에 골막하 농양을 형성- Bozold씨 유돌염), 고막은 발적, 비후 및 팽윤, 이루(급성중이염 발생후 2주 지나도 감소되지 않거나 감소되었던 이루가 다시 증가)

- 진단기준: 발병 2~3주 후 유양돌기부의 부종, 발적, 이후부의 종창, 외관상 외이도 후벽의 하수, 급성중이염이 2주 이상 경과해도 계속되는 이루, 농즙. 방사선 소견에서 유양봉소의 혼탁.

<분류>

1) 급성 유양돌기염 : 급성 화농성 중이염으로 고막에 천공이 생긴 후 耳痛이 감소하지 않고 청력이 회복되지 않으며 頭痛이 나타나고 이루가 증가하고 발열이 지속. 외이도 상벽이 下垂. 유양돌기 표면을 누르면 壓痛

2) 만성 유양돌기염 : 귀속에 장기간 혹은 간헐적인 膿이 유출. 骨瘍型(고실내 肉芽나 瘻肉이 발생). 膽脂瘤型(灰白色의 인설이나 두부 찌꺼기 같은 것이 있고 이상한 냄새 동반)으로 분류. 청력검사상 전음성 난청, 오래되면 혼합성 난청

<변증론치>

- 1) 급성기 : 龍膽瀉肝湯合黃連解毒湯
- 2) 濕熱蘊結 : 草薢滲濕湯
- 3) 脾虛濕困 : 托裏消毒散
- 4) 脾腎陽虛 : 溫腎健脾湯
- 5) 腎陰虧虛 : 知柏地黃湯

→ 급성은 습열의 범주 / 만성은 비허, 신허의 범주

耳根毒(耳根癰) 이근독(이근옹)

★ 이문옹, 이풍독, 이근독 양방병명, 증상 차이를 쓰시오. (03,06,09,10)

- 유양돌기염, 이후의 골막하농양
- 초기 전신증상과 함께 耳後 完骨部の 피부가 초기에는 발적되다가 점차적으로 여러 형태의 종창(結核狀, 蜂房狀, 胡桃狀, 伏鼠狀 등), 동통, 파동감과 압통이 있는 후에 껍파, 유농함

- 구분

① 耳根毒 - 耳垂後 縫中 및 耳後完骨部

② 發耳 - 膽經인 客主人과 懸釐穴

③ 杼疽(化骨瘡, 灸瘡) - 天牖과 翳風穴의 양방 및 頸上의 양측 耳後

④ 首疽 - 瘰癧과 翳風穴

- 원인 및 치료

① 급성 - 肝膽火熱, 手足少陽經의 風熱이 相搏하여 - 荊防敗毒散, 荊芥連翹湯, 柴胡清肝散

② 만성 - 氣血不足, 肝腎虧損으로 餘毒未清하여 혹은 邪毒이 반복적으로 침입하여 黃芪內托散, 千金內托散 등

04

내이질환

耳鳴(tinnitus) 이명

★ 실증이명의 특징으로 틀린 것은? (10)

- 귀울림, 즉 耳鳴은 귀 밖에 音源이 없이 音을 감각하는 증상

- 발병 기전 : 迷路血管 障礙說

→ 미로동맥 및 내이동맥에 혈관운동의 이상과 혈관투과성 이상으로 미로동맥에 허혈, 빈혈 등의 혈관장애가 발생되면 내림프액의 순환도 깨져서 내림프액의 분비흡수가 변화하여 내림프액의 조성변화 및 내림프압에도 이상이 생겨 內淋巴水腫(내림프수종)이 되어 Reissner 막과 구형낭 막에 특징적인 팽창이 된다는說

<耳鳴>

- 귀울림(Tinnitus ; ear-ringing).

- 耳鳴은 音源이 없이 耳竅內에서 자각적으로 소리가 울리는 포괄적인 症候

- 心身疾患과 밀접한 관계.

- 내이질환인 메니엘씨 증후군, 돌발성 난청, 노인성 난청, 내이염, 여러 가지 질환에 의한 내이장애, 외상 및 음향외상성의 내이장애, 청신경종양 등에서 발생

- 모든 사람의 약 95%가 완전 방음된 조용한 방에서 20dB이하의 이명을 느낌

★ 허실 감별 ★

1) 실증 → 1~3번은 꼭 외워두기. 4번은 크게 의미가 없음

① 肝火上擾, 痰火阻塞, 風熱의 辨證.

② 양상은 突發的, 持續的,

③ 鳴音이 크고 閉塞感, 頭重과 격렬한 眩暈이 발생,

④ 手按하면 鳴音이 더욱 커진다.

2) 허증

① 氣虛, 血虛, 腎陰虛, 腎陽虛, 心腎不交, 脾胃虛弱의 辨證.

② 양상은 間歇的,

③ 鳴音은 크지 않으나 勞倦 過多나 야간에 鳴音이 커지며, 眩暈은 경미하게 持續的,

④ 手按하면 鳴音이 감소되거나 不鳴해진다.

이명의 병태생리

- 소음이나 두경부 외상 등으로 인해 와우내의 **유모세포가 손상**되어 반복적으로 자극을 받아 실제 음자극을 구별하지 못하고 중추 청각경로를 자극하여 소리가 발생하는 것으로 인식

이명의 분류

자각적 이명	저주파의 단속적인 이명	전음계 장애
	고주파의 단속적인 이명	감음계, 중추신경계 장애
	난청을 동반하는 이명	* 저음의 간헐적 이명, 전음성 난청 동반 - 외이도 이구 및 이물, 외상성 고막천공, 삼출성 중이염 * 고음의 지속적 이명 - 만성 유착성 중이염, 메니에르 병, 이경화증, 노인성 난청, 청신경종양, 음향외상
	난청이 없는 이명	이과적으로 특별한 원인 없는 경우 - 동맥경화증, 고혈압, 빈혈, 내분비장애, allergy, 전신쇠약 등
타각적 이명	이관의 이상개방(파도소리 같은 이명), 정신적 긴장, 연구개근의 경련, 동·정맥류(맥관성 이명, 두명)	

타각적 이명의 종류

- 지속적 이관개방
 - 파도소리와 비슷, 간혹 자가강청
 - 이경검사상 고막이 호흡음과 일치하여 진동
 - 누우면 증상 호전되고 머리를 앞으로 기울이면 이명 소실이 특징
 - 출산후, 항암치료후, 갑자기 체중 감소한 경우 주로 발생
- 정맥성 잡음
 - 제2경추 횡돌기가 경정맥을 압박하거나 경동맥의 맥박이 경정맥에 전달될 때 발생
 - 정상인의 52%에서 발생가능
 - 대부분 심박출량의 증가와 유관
- 혈관 기원성 증양
 - 경부압박, 두위변화, 자세변화, Valsalva법에도 특별한 영향 안받음(정맥성 잡음과 감별)

4. 동정맥기형

- 후두개와에 위치한 후두동맥과 횡정맥동 사이에서 호발
- 하악골이나 경동맥과 해면정맥동 사이에서도 발생
- 심장박동과 일치하여 발생

5. 근수축성 이명

- 심박동수보다 빈도가 높음 (60~200회/분)
- 운동시에도 특별한 변화 없음

이명의 변증별 분류

★ 다음과 같은 이명 증상을 호소하는 환자의 진단명과 한의학적 치료법을 쓰시오. (03)

1) 風熱耳鳴

- ① 원인 : 膿耳에서 熱毒이 未清되거나 風邪 혹은 風熱邪毒이 침입되어 발생.
- ② 증상 : 風聲 혹은 耳中에 風吹하는 鳴音, 기이한 癢痒, 고막이 胪파되고 膿液이 時流時止하며 頭痛, 惡寒發熱, 鼻塞, 流涕 등.
- ③ 치료 : 銀翹散, 蔓荊子散, 荊芥蓮翹湯, 酒製通聖散加味, 芎芷散과 芎歸飲.

2) 肝火耳鳴

- ① 원인 : 多怒, 暴怒, 鬱怒로 肝氣鬱結되고 肝火上擾하여 돌발적으로 발생.
- ② 증상 : 風雷聲, 雷聲과 같은 鳴音과 頭痛, 眩暈, 煩燥不安, 顏面紅潮, 口苦咽乾, 不眠 등.
- ③ 치료 : 龍膽瀉肝湯, 柴胡清肝湯, 加減龍薈丸, 丹梔逍遙散加味.

3) 痰火耳鳴

- ① 원인 : 肥厚한 사람이 膏粱厚味, 炙燂 등을 과다하게 섭취하여 水濕이 停聚되고 痰濕이 乃成된 것이 오래되어서 痰火가 上擾하여 발생.
- ② 증상 : 耳中이 폐색된 것과 같은 격렬한 耳鳴, 때로 경미한 耳聾을 겸하기도 하며 頭重, 胸脘溝悶, 咳嗽痰多, 嘔吐痰涎, 口中粘膩, 便溏 등.
- ③ 치료 : 清氣化痰丸, 複聰湯, 聰聰化痰丸, 半夏白朮天麻湯과 通明利氣湯加味.

4) 腎虛耳鳴

- ① 원인 : 腎精不足되고 髓海가 空虛해져 耳竅를 濡養하지 못하거나 혹은 腎水不足한 상태에서 風邪 혹은 外感邪熱이 침범해 발생.
- ② 증상 : 鳴聲이 다양하면서도 細小하고 사려, 노역과다나 야간에 특히 鳴音이 커지며 점

차적으로 耳聾이 되고 腰膝酸軟, 遺精, 手足心熱, 盜汗 등.

③ 치료 : 腎精不足한 경우에 附桂八味丸, 滋腎通耳湯, 六味丸, 八味丸加減을, 腎虛한 때에 風邪가 침범하여 발생된 경우에는 먼저 五苓散加味合 青木香元 투여 후 芎歸飲, 또는 六味地黃丸合五苓散加味, 雙和湯.

5) 心腎不交耳鳴

- 血虛, 氣虛, 腎虛耳鳴을 포함하고 있는 증후.

① 원인 : 사려과도, 구병, 대병, 노역 등으로 精血이 소모되어 心の 陰血과 腎의 陰精이 虛損해져 心火와 腎水의 밀접한 관계가 유지되지 않아 발생.

② 증상 : 心の 陰血不足으로 心悸, 怔忡, 健忘, 多夢不眠, 虛煩, 易驚, 腎의 陰精不足으로 耳鳴, 潮熱, 盜汗, 口乾, 遺精, 早漏.

③ 치료 : 天王補心丹, 清心地黃湯, 四物歸脾湯, 婦人의 心氣不平으로 心神의 피로, 쇠약과 겸하면 祛痰清心湯, 柴胡 加龍骨牡蠣湯, 四物安神湯加減, 傷寒病과 병발되면 黃連阿膠湯.

<참고>

1) 氣虛耳鳴

① 원인 : 中氣(胃氣) 虛弱, 重病 後.

② 증상 : 耳鳴이 때때로 발생, 精神 易疲勞, 四肢無力, 面黃, 飲食無味, 大便溏泄.

③ 치료 : 加味補中益氣湯, 加味四君子湯.

2) 血虛耳鳴

① 원인 : 產後에 下血過多하거나 失血 등으로 血液不足.

② 증상 : 耳鳴이 때때로 발생. 口渴, 便秘, 心悸怔忡, 面無華色 蒼白, 指甲에 潤氣 없다.

③ 치료 : 加味四物湯, 加味歸脾湯.

3) 膽虛耳鳴

① 원인 : 少陽의 膽氣가 원할치 못한 중에 風邪가 침범하여 火가 소산되지 못하므로.

② 증상 : 兩耳腫痛, 耳內流水 變膿血, 寒熱, 不安, 焦燥, 정신적 자극에 민감해진다.

③ 치료 : 溫膽湯, 歸脾湯.

4) 陽虛耳鳴

① 원인 : 陽虛

② 증상 : 耳가 腫痛하여 치료후에도 계속 耳鳴.

③ 치료 : 加減八味丸.

5) 聾耳(膿耳)性 耳鳴

① 원인 : 중이염, 내이염, 이경화증 등에 의해 발생.

② 증상 : 耳內에서 膿이 배출되면서 耳鳴. 急性은 耳內疼痛하며 頭重感, 惡臭 등.

③ 치료 : 蔓荊子散, 托裏消毒飲, 仙方活命飲.

6) 中毒性 耳鳴

① 원인 : 약물(독극물)이나 가스 중독에 의해 발생.

② 증상 : 眩暈, 口吐, 의식 및 언어장애, 頭重, 難聽을 수반하는 耳鳴.

③ 치료 : 防風通聖散, 黃連解毒湯.

이명의 침구치료

① 體鍼 - 耳竅 周圍(耳門, 聽宮, 聽會)

頭頸部(下關, 風池, 啞門, 翳風, 角孫, 瘰癧, 廉泉)

四肢部(支正, 外關, 中渚, 陽陵泉, 三陰交, 太衝, 丘墟, 合谷, 曲池穴)을 刺鍼.

② 耳鍼 - 神門, 腎, 腎上腺, 內分泌, 枕, 內耳點.

③ 藥鍼 - 翳風, 聽宮, 完骨, 瘰癧穴에 當歸, 麝香液(BUM)을 注入.

④ 舍岩鍼 - 腎正格(經渠·復溜 補, 支溝·陽輔 瀉).

血虛耳鳴(小腸正格),

火氣가 너무 세서 발생하는 耳鳴(膀胱正格)

⑤ 동씨침 - 驪馬上·中·下(風市穴 內側 3寸處 상하 각 2寸),

腎關(=天皇副; 陰陵泉下 1.5寸)

→ 실증 : 소양경 / 허증 : 소음경

난청(hearing disturbance)

- 내이질환의 일차적인 증상은 난청, 이명 및 현훈.
- 와우각 이상, Corti 기관 내의 유모, 지지세포의 변성, 이소골의 경화로 발생.
- 최근 돌발성 난청(일측, 양측에 감각신경성 난청, 원인불명)이 증가추세.

난청의 감별법 (참고)

난청		
발현시기	선천성 난청	기형, 유전성 난청, 모성감염
	후천성 난청	소아기(이관염, 아테노이드 증식증, 비인두염, 중이염) 사춘기의 여성(이경화증)
병변부위	전음성 난청	외이질환, 중이질환
	감각신경성 난청	내이질환, 중추신경질환, 이독성 약물에 의한 내이장애
발현양상	돌발성 난청	음향외상성, 중독성 내이장애와 원인불명의 병인에 의한 질환
	진행성 난청	이경화증, 내이매독, 각종 약물중독성 내이장애, 메니에르병
이상청각		
Wills 착청	이경화증의 발생시, 기타 전음성 난청	
자가강청	급성 이관염, 삼출성 중이염	
복청	메니에르 증후군	
청각과민	안면신경마비의 후유증으로 생기는 등골근의 마비, 급성 이관염	
이충만감	외이도耳垢, 급성 이관염, 삼출성 중이염, 항공성 중이염, 이경화증, Meniere병	

1) 유전성 난청

- 聾啞
- 최근 백신의 출현으로 인플루엔자, 홍역, 유행성 이하선염 등의 감염질환이 감소하고 이독성 약물이나 사고로 인한 내이손상도 줄어 상대적으로 유전성 난청의 발병률이 증가
- 난청의 원인: 유전성(약 50%), 환경적 원인(20~25%), 원인불명(25~30%)
- 치료: 약물치료 무의미. 잔여청력을 이용해 가능한 한 빨리 언어훈련

2) 전염중독성 난청

- 溫毒聾, 疫毒聾
- 각종 전염성 질환의 후유증. 난청은 질환의 중간단계, 또는 앓은 후에 발생
- 청력검사상 감각신경성 난청
- 치료: 원인이 되는 전염병의 치료에 집중. 예방접종을 시행하여 각종 전염병을 예방

3) 이독성 난청

- 藥毒聾
- 약물중독성 난청
- 이독성 약제: 항생제, 이뇨제, 소염제, 말라리아 치료제, 항암제, 국소 점액액, 산업 화학 물질, 음식물 및 기타 물질 등
- 내이의 청각 및 전정기관의 손상으로 청력소실, 이명, 현훈 등이 발생
- 예방이 중요. 약물을 반드시 사용해야 하는 경우 처음 투여시 반드시 최소량으로 시작 하여 중간정도량에서 중지, 정기적으로 청력과 전정기관을 검사하여 이상을 조기 발견
- 이독성 난청의 변증론치
 - 1) 精虧毒滯 : 耳聾左慈丸, 益氣聰明湯, 補中益氣湯
 - 2) 痰阻風動 : 滌痰湯加減
 - 3) 痰瘀交阻 : 蠲毒聰耳丸

4) 소음성 난청

- 噪聲聾
- 직업성 난청. 돌발적 감각신경성 난청. 산업화 사회에서 중요한 장애 중 하나
- 음향외상, 일시역치변동, 영구역치변동으로 분류
- 소음의 병리기전은 와우의 외유모세포 손상, 점차 지주세포, 내유모세포 손상되어 와우 신경핵의 위축을 초래
- 순음청력검사상 초기 ★ 4kHz ★ 에서만 경도 난청(C5 dip 소견)
- 꼭 외워두기. 초기에 청력검사에서 소음성 난청 판별할 수 있는 중요한 기준임
- 치료: 확진되면 치료방법은 없으므로 사전 예방이 중요

<소음성 난청의 분류>

1. 음향외상: 폭발음 같은 강력한 음에 단기간 노출된 후 발생
2. 일시역치변동: 소음에 노출된 후 휴식기간을 가지면 청력이 회복되는 일시적, 가역적 청력손실
3. 영구역치변동: 장기간 소음에 노출된 후 회복되지 않는 비가역적 감각신경성 난청

<작업환경의 소음 허용한계>

- 보통 85~90dB을 초과하지 않도록 규정
- 초과 작업장은 반드시 개인 청력보호장구 착용을 의무화

5) 노인성 난청

- 퇴행성 변화로 인한 청력감소
- 30대부터 시작되어 ★ 1kHz ★ 부근의 회화영역에 청력감소가 발생. 40~60세 때 청력저하 인지. 남자가 여자보다 2배정도 빠르게 진행 → 이것도 숫자 꼭 외워두기
- 증상: 양측 고주파 영역에 경도 혹은 중등도의 청력감소가 발생하고 소리의 방향을 감지하는 능력이 저하됨
- 청력검사상 저주파 영역은 정상, 고주파 영역에서 떨어지는 하강형
- 노인성 난청의 변증론치
 - 1) 腎精虧損 : 左歸丸加減, 杞菊地黃湯
 - 2) 腎陽虛弱 : 右歸丸加減
 - 3) 單驗方 : 胡桃肉

<노인성 난청의 기준>

1. 청력검사상 양측 귀의 대칭적 난청 양상
2. 외상, 이독성 약물, 귀질환, 소음 노출, 귀 수술 등의 과거력이 없을 것
3. 최소한의 전음성 난청(10dB 이하)
4. 65세 이상의 연령
5. 가족력이 없을 것

★ 소음성 난청 vs 노인성 난청 ★

→ 차이점 잘 알아두기

★ 노인성난청과 소음성난청을 난청의 진행 양상 및 순음청력검사상 특이소견으로 비교하여 감별하시오. (19)

소음성 난청	소음 폭로 후 급격히 일어나고 더 이상 크게 증가하지 않는 감속과정 을 취함
노인성 난청	처음에는 서서히 증가하나 나이가 많아질수록 급격히 증가 하는 가속과정 을 취함

★ 순음청력검사상 소음성 난청은 ()kHz, 노인성 난청은 ()kHz에서 청력감소를 보이며, 돌발성 난청은 3개 이상의 연속된 주파수에서 ()dB 이상의 감각신경성 청력손실이 발생한다. (09,12,19) 답 : 4, 1, 30

+ 40dB까지가 경도성 난청. 40dB 정도가 사회생활이 가능한 정도의 데시벨이기 때문

+ **지난주에 수업한 '순음청력검사' 표 꼭 알아두기**

6) 돌발성 난청(暴聾, 卒聾)

- 확실한 원인 없이 수시간 또는 2~3일 이내에 순음청력검사상 3개 이상의 연속된 주파수에서 30dB 이상의 감각신경성 청력손실이 일측 또는 양측 귀에 발생한 경우
- 환자의 1/3에서 아침 기상시에, 1/2 정도에서는 현훈 동반
- 원인: 불분명. 바이러스 감염, 혈관장애, 와우막 파열, 자가면역질환, 청신경종, 두부외상 등
- 치료: 입원치료 원칙. 절대안정 상태에서 스테로이드, 소염제, 혈액순환 개선제, 혈관확장제, 항바이러스제, 이뇨제 등 사용
- 예후: 대개 발병 1~2주내에 자연회복율이 40~60%

- 돌발성 난청의 변증론치

- 1) 邪遏少陽 : 柴胡聰耳湯
- 2) 肝鬱化火 : 丹梔逍遙散, 柴胡疏肝散合通氣散, 聰耳蘆薈丸
- 3) 氣血瘀阻 : 通竅活血湯合通氣散, 補陽還五湯
- 4) 心脾兩虛 : 歸脾湯加減
- 5) 陰精虧虛 : 滋陰地黃湯

耳聾 이론

- 선천적인 청력장애인 聾啞 및 노인성 난청, 내이염, 이독성 약물, 외상, 음향외상성 내이장애, 돌발성 난청, 메니에르병 등으로 유발되는 난청을 포괄하는 症候
- 耳聾은 청력이 감퇴되어 聲音이 전혀 들리지 않는 증후, 重聽은 들리기는 하지만 聲音이 뚜렷하지 않은 難聽의 증상

이론의 분류 → 빠르게 넘어가심. 별로 안 중요한듯

1) 病因에 따라

(1) 4종 분류

- ① 厥聾 : 오장육부, 十二經脈의 陰, 陽 經氣가 결합될 때 臟氣가 逆하여 厥하게 되어 厥氣가 耳內로 침범하여 발생 - 때때로 眩暈症
- ② 風聾 : 脈絡이 허약한 때에 風邪가 침입하여 耳內로 上衝되어 발생. 때때로 두통
- ③ 勞聾 : 勞傷氣血, 色慾過多하여 腎精不足으로 발생
- ④ 久聾 : 耳聾이 있는데도 불구하고 勞役過多하거나 혹은 風邪의 침입으로 울결되어 발생

(2) 5종 분류

- ① 痰火聾 : 고랑후미를 과다섭취하여 胃熱 상승 - 兩耳 蟬鳴, 眼花, 耳聾
- ② 風聾 : 風邪의 침입으로 발생 - 耳內 癢痒, 頭痛, 耳聾
- ③ 濕聾 : 雨水, 목욕, 오염된 물이 耳內에 침입 - 耳內腫痛, 眩暈, 耳鳴
- ④ 虛聾 : 久瀉, 大病, 久病 後에 허약할 때 風邪의 침입으로 발생
- 耳鳴, 黑花, 耳聾
- ⑤ 勞聾 : 노력과다로 元氣가 虛弱해져 脫氣되거나 혹은 腎精不足 또는 陰虛 火動으로 발생

2) 部位에 따라

- ① 左耳聾 : 분노과도하여 膽火가 동한 것, 주로 婦人에 다발, 耳聾中 最多.
- ② 右耳聾 : 색욕과도하여 相火가 동한 것, 주로 男子에 다발.
- ③ 左右俱聾 : 고랑후미를 과다하게 섭취하여 胃火가 上衝한 것, 주로 肥甘人에 다발.

3) 發病의 期間에 따라

- ① 돌발적으로 發生 : 暴聾, 卒聾, 厥聾 - 肝火, 痰火, 氣滯血瘀, 風邪 侵入.
- ② 점차적으로 發生 : 勞聾, 虛聾 - 心血不足, 腎陰虧損, 心腎不交.

★ 이규가 폐쇄되는 병인에 따른 이동분류 5가지를 서술하시오. (04)

4) 耳竅가 閉塞되는 病因에 따라

- ① 火閉 : 耳에 絡한 經絡의 火가 上衝되어 耳竅를 壅塞
- 脹悶, 煩熱, 頭面紅赤.
- ② 氣閉 : 분노, 우울로 인해 肝膽의 氣逆으로 발생
- 火나 虛弱으로 나타나지는 않음.
- ③ 邪閉 : 風寒과 外感이 營衛를 혼란케 하여 발생.
- ④ 竅閉 : 外傷, 耳內瘡, 膿耳 등으로 潰膿不止하여 耳竅를 閉塞시켜 발생.
- ⑤ 虛閉 : 老年, 노권, 색욕과다, 大病, 久病 後에 精脫하고 腎虛하여 발생.

변증별 분류 및 치료

1) 風熱耳聾

- ① 원인 : 風邪(風寒, 風熱)가 침범하여 발생.
- ② 증상 : 돌발적으로 耳聾, 耳痒, 蟬鳴 / 頭痛, 惡寒發熱, 鼻塞流涕.
- ③ 치료 : 銀翹散, 芎芷散, 蔓荊子散, 酒製通聖散.

- 風邪襲虛로 인한 耳聾은 桂香散을, 風火로 인하면 桂星散을, 風寒을 겸하면 六安煎加減을 사용.

2) 風濕耳聾

- ① 원인 : 風濕邪의 침입, 雨水, 목욕, 오염된 물이 耳內에 들어오거나 肝膽濕熱, 脾胃濕熱로 인해 濕熱이 울체되어 발생.
- ② 증상 : 귓속이 隆隆한 소리가 나면서 耳聾, 耳垢多 / 頭重痛, 身重, 口不渴, 耳脹悶 및 腫痛, 流膿.
- ③ 치료 : 涼膈散, 五苓散加味. 이외 膿耳의 治療法을 活用.

3) 肝火耳聾

- ① 원인 : 정지불서로 인해 肝火上逆하거나 肝腎陰虛한데 肝陽이 上逆하여.
- ② 증상 : 돌연히 耳聾, 耳內脹滿 / 面紅目赤, 口苦咽乾, 躁急易怒, 胸脇脹痛.
- ③ 치료 : 當歸龍薈丸, 天麻鉤藤飲, 龍膽瀉肝湯, 小柴胡湯加減, 逍遙散加味.

4) 痰火耳聾

- ① 원인 : 고랑후미, 醇酒를 과다하게 섭취하여 濕痰이 정체되고 痰火上擾.
- ② 증상 : 돌연히 耳聾, 蟬鳴, 聲音不清, 耳脹悶, 閉塞感
/ 頭重如窠, 胸膈滿悶, 咯痰黃稠.
- ③ 치료 : 清氣化痰丸, 二陳湯加減, 滾痰丸.

5) 氣滯血瘀로 인한 耳聾

- ① 원인 : 칠정울결로 氣機 閉塞, 經氣 不行하므로 氣滯血瘀가 되어.
- ② 증상 : 주로 婦人에서 다발. 耳脹悶, 脹痛感이 있다가 돌연히 耳聾
/ 失眠, 心痛, 胸悶, 口脣青紫, 咯血, 月經不調, 少腹痛, 舌上瘀斑.
- ③ 치료 : 通竅活血湯, 順氣活血湯, 六安煎加減.

6) 腎虛耳聾

- ① 원인 : 노역, 대병, 노령 등으로 腎陰虧損, 肝腎陰虛, 虛火上炎하거나 腎氣不足한데 風邪가 侵入해서 發生.
- ② 증상 : 耳聾이 점진적 / 面色㿔白, 虛煩失眠, 遺精, 腰膝痠軟, 五心煩熱.
- ③ 치료 : 腎陽不足(附桂八味丸, 右歸丸), 腎陰不足(六味地黃丸, 坎離丸)
- 腎虛한 때에 風邪가 침입해 발생된 卒聾에는 芎芷散, 淸神散.

7) 氣虛耳聾

- ① 원인 : 음식부절, 노권, 사려과다 등으로 脾胃損傷되어 氣血虛弱해져 발생.
- ② 증상 : 耳鳴이 있는 후에 점차적으로 耳聾(때로 輕하거나 重함)
/ 倦怠無力, 食慾不振, 氣短懶言, 面蒼萎黃.
- ③ 치료 : 補中益氣湯, 益氣聰明湯, 人蔘養榮湯, 歸元湯加減.

8) 心腎不交로 因한 耳聾

- ① 원인 : 腎陰不足으로 髓海空虛하거나 또는 心血이 耗損되어서 心火抗盛하므로 心腎이 不交되고 氣血이 逆亂되어 發生.
- ② 증상 : 耳鳴이 미약하게 있는 후에 耳聾
/ 心血不足(心悸, 怔忡, 健忘, 多夢不眠, 虛煩, 易驚),
腎陰不足(潮熱, 盜汗, 口乾, 遺精, 早漏).
- ③ 치료 : 天王補心丹, 四物歸脾湯, 養心湯合炙甘草湯, 四物安神湯,
祛痰淸心湯加減.

9) 中毒性耳聾

- ① 원인 : 약물, gas, 음식물에 의한 중독으로 發生
- ② 증상 : 중독 후 바로 양측성 耳鳴, 耳聾 / 高熱, 意識障礙를 수반하기도 함.
- ③ 치료 : 초기(黃連解毒湯, 紫金錠), 후기(滋腎通耳湯, 八味丸, 歸脾湯)

10) 外傷性耳聾

- ① 원인 : 頭部 타박에 의한 손상, 뇌진탕, 안구진탕 등
- ② 증상 : 耳鳴, 耳聾 / 頭痛, 惡心, 眩暈하면서 迷路骨折, 鼓膜破裂 등을 수반.
- ③ 치료 : 초기(當歸鬚散, 當歸飲 복용후 通明利氣湯),
후기(磁石羊腎丸, 滋腎通耳湯, 滋陰地黃湯)

11) 耳重聽(難聽)

- ① 원인 : 先天的으로 腎氣不足하거나 성생활 과도로 腎氣가 虛弱해져 발생
- ② 증상 : 타인이 말할 때 수차 귀를 기울이며 反問하고
/ 眩暈, 頭目不清, 身體瘦弱 등.
- ③ 치료 : 頭目不清하면서 耳重聽인 경우 淸神散을,
他症狀이 없고 단지 耳重聽인 경우 聰耳湯을 사용.

이릉의 실증 및 허증

실증	허증
돌발적	점차적
厥聾, 卒聾, 新聾	勞聾, 虛聾, 久聾
多熱	多虛
肝火, 胃火, 痰火熱盛	腎陰虧損, 肝腎陰虛, 虛火上炎
病邪의 왕성으로 氣逆이 되어 폐색된 것	氣不足으로 폐색된 것, 주로 實證보다 많다.

이릉의 침구치료

- ① 體鍼 - 耳竅 周圍(이문, 청궁, 청회, 예풍)와 少陽經穴(외관, 중저) 기본.
加 腎虛 - 신수, 조해, 삼음교
肝逆 - 행간, 태충
脾虛 - 족삼리, 관원, 비수 刺鍼.
- ② 耳鍼 - 腎, 枕, 內耳, 腎上腺, 三焦, 耳尖, 神門穴點.
- ③ 藥鍼 - 聽宮, 翳風, 完骨, 瘰癧穴에 丹參, 當歸, 麝香液을 水鍼
- ④ 頭皮鍼 - 暈聽區.
- ⑤ 舍岩鍼 - 腎正格(經渠·復溜 補, 支溝·陽輔 瀉), 難聽 - 肝正格.

평형장애(어지럼증)

1) 메니에르 증후군 (Meniere's syndrome complex)

★ 메니엘씨 증후군에 대해 동서의학적으로 설명하시오. (00,02)

★ 메니에르 증후군의 주요 증상 3가지, 한의학적 변증 3가지를 쓰시오. (11,14,17)

→ 빨간색으로 강조한 부분 꼭 외워두기

- 뇌신경계의 기질적인 병변 및 내이 미로에 화농성 질환이 없이 ★회전성 현훈, 이명, 저음성 감각신경성 난청★의 특징적인 3대 증상과 이내충만감, 압박감, 오심, 구토 등이 발작적으로 반복되고 수분에서 수시간 혹은 수년에 걸쳐 消長을 보이며 지속

- 호발연령은 30~50대, 여성이 남성의 1.3배

- 한의학적으로 肝火耳鳴, 痰火耳鳴, 心腎不交로 인한 耳鳴, 耳重聽, 厥聾과 비슷

- 원인: 림프액의 과생성, 외림프액과 내림프액 사이의 기능장애, 내림프액의 흡수장애로 인한 내림프수종. 이는 체질적 소인, 알레르기, 내분비 장애, 자율신경 긴장이상, 갑상선 기능저하증, 스트레스, 영양장애 등으로 유발

- 변증론치 : 초기 발병환자 중 80%가 자연치유 가능

① 肝火 : 정지불서로 인해 肝氣鬱結, 肝火上擾하여 - 耳鳴과 眩暈이 돌발적

- 天麻鉤藤飲, 龍膽瀉肝湯, 羚羊角散加減

② 痰火 : 음식부절과 고량후미 등으로 인해 水濕停聚, 痰火上擾

- 堵塞感, 격렬한 耳鳴과 경미한 耳聾이 겸함

- 半夏白朮天麻湯, 清暈化痰湯

③ 心腎不交 : 心陰血 및 腎陰精不足의 증상을 겸함

- 歸脾湯加減, 杞菊地黃丸加減

- 치료 : 정신적 안정과 함께 1일 1g의 ★저염식★. 유효 약물(급성-Diazepam의 전정억제제, 만성-Betahistidine, 이노제)

→ 이노제를 쓰는 이유 : 소변으로 림프액을 빼줘야하기 때문

→ 근데, 여기서 염분이 높은 음식을 먹게되면 림프액이 빠지지 않기 때문에 저염식 필수

- streptomycin, gentamycin 고실내 주입법: 와우 독성 유발로 청력 저하시킴

- 내임파수종: 와우관의 확대에 의한 레이스너막의 확대, 전정계 및 고실계의 협소, 구형 및 난형낭의 팽창이 특징

1. 진성 메니엘씨 증후군: 현훈, 이명, 난청 포함

2. 가성 메니엘씨 증후군

1) 와우형: 현훈없이 난청, 이명, 충만감만 발생

2) 전정형: 난청없이 반복성 현훈만 발생

- Tumarkin 발작 : Meniere병 환자가 의식 소실 없이 갑자기 쓰러지는 현상. 와우의 허혈이 수종으로 인해 발생하고 막미로의 파열로 인해 내이압력이 완화되어 발생

- 변증론치

1) 風陽上搖 : 鎮肝熄風湯

2) 痰濕中阻 : 半夏白朮天麻湯

3) 精虧髓虛 : 杞菊地黃湯

4) 心脾兩虛 : 歸脾湯加減

5) 寒水上泛 : 眞武湯合五苓散

6) 痰瘀交阻 : 二陳湯合血府逐瘀湯

→ 수습, 습담과 관련된 처방. 반하백출천마탕, 오령산

★ 청력역치를 기준으로 한 메니에르 증후군의 병기 ★

병기	청력역치
1	≤ 25dB
2	26 ~ 40dB
3	41 ~ 70dB
4	> 70dB

2) 전정신경염(vestibular neuronitis)

★ 난청이 동반되지 않는 급성 편측성 말초전정계 질환이며 증년에서 호발. 발병 1~2주 전에 외감병력이 있고 돌발적 현훈이 점차 두위성 현훈을 이루게 되는데 이명이나 이롱은 없다. 온도 안진 검사시 병변쪽 귀의 반규관 마비가 있고 6개월후 증상이 자연 소실되는 질환의 양방병명은? (09,11,14,17)

- 30~50대에서 겨울과 봄에 다발. 남녀 성비는 비슷

- 주요 원인 : 감염으로 인한 신경계의 염증(상기도 감염, 위장관염, 헤르페스 감염, 이하선염 등)

- 급성 전정신경염은 양성 발작성 체위변환성 현훈을 동시에 호소할 수 있음

- 증상 : 발병전 1~2주에 외감의 병력, 돌발적 현훈이 발생, 지속되어 몇시간에서 며칠 사이에 최고조에 도달 후 점차 두위성 현훈이 됨. 오심, 구토를 동반할 수 있으나 이명, 이롱은 없다. 이외 발열, 두통, 전신부적감 등이 동반

- 진단

- ① 난청이 동반되지 않는 급성 편측성 말초전정계 질환으로
- ② 중년에 호발하고
- ③ 심하고 지속적인 현훈이 한차례 있는데,
- ④ 온도안진검사상 병변 쪽의 반규관마비가 있고,
- ⑤ 6개월 이내에 증상이 완전히 소실되는 경우(Coates의 5가지 진단기준)

+ 병변의 반대측으로 자발성 수평회전성 안진 발생

- 변증론치

- 1) 膽經痰熱 : 小柴胡湯合溫膽湯
- 2) 肝陽上亢 : 天麻鉤藤飲
- 3) 痰濁瘀阻 : 半夏白朮天麻湯合通竅活血湯

- 치료 : 대증요법(전정계 억제제, 오심 억제제 사용)

3) 양성 발작성 체위 변환성 현훈 (BPPV; Benign paroxysmal positional vertigo)

★ 32세 여자환자가 오늘 아침에 일어나려는데 갑자기 심한 회전성 현훈이 발생하여 벽에 기대고 1분이 지나 소실되었고, ~ 검사해보니 심한 현훈과 회전성 안진이 유발되었고 오심, 구토가 동반되었으며 청력은 정상이었다. 이외에 두창, 두통, 홍혈창민, 설홍태황 맥현의 증상을 보였다. 서의학 병명, 변증, 수기법은? (10,12,15,17,18,19)

- 머리의 위치를 바꿀 때 안진과 현훈이 발생하는 질환. 대부분 후반규관 병변에서 다발
- 원인 : 이석막의 자연변성, 두부외상, 수술, 메니엘씨 증후군, 미로염 등에 의해 내림프액보다 밀도가 높은 이석 조각들이 떨어져 나와 비정상적인 내림프 흐름을 유발하여 발생
- 증상 : 남성보다 여성에 다발(1 : 1.6~2). 주로 아침에 자리에서 일어날 때 혹은 앉은 자리에서 누울 때에 심한 회전성 현훈이 발생, 주로 1분 이내로 짧게 지속 후 소실됨. 안진은 30초 이내 발생 반복. 청력은 정상이며 예후는 양호
- 진단 : Dix-Hallpike 유발검사법(환자를 앉은 위치에서 45도 환측으로 돌린 후 급히 눕히면서 머리를 검사대보다 뒤로 20° 정도 젖히면서 아래로 떨어뜨리고 1~2초 후 안진을 관찰. 심한 현훈과 향지성, 회전성 안진이 유발됨)

- 치료

- ① Epley 법 : 환자의 머리를 환측으로 45도 돌린 후 천천히 눕혀 머리를 몸체보다 아래로 위치 후 30초~1분유지 머리를 반대편으로 90도 돌리고 머리와 몸의 각도를 유지한 채 30초~1분유지 몸을 건측으로 돌려 측와위로 30초~1분 유지, 머리는 건측으로 135도 상태임 환자를 부축하면서 서서히 일으켜 처음 앉은 자세로 전환

② Semont 법 : 머리는 수기 내내 건측방향으로 45° 회전시킨 상태를 유지 그 상태에서 몸을 환측으로 신속히 눕히고 1~2분 기다림 환자의 몸을 건측으로 신속히 눕히고 1~2분 기다린 후 앉은 자세를 취함

+ Barbeque 법 : 수평반고리관형 → 바비큐를 건측으로 돌리는 양상

- 변증론치

1. 肝陽上亢: 진간식풍탕, 천마구등음
2. 痰濁中阻: 반하백출천마탕
3. 痰瘀交阻: 이진탕합혈부축어탕
4. 腎虛精虧: 기국지황탕
5. 心脾兩虛: 귀비탕
6. 寒水上泛: 진무탕합오령산

기타질환(이경화증, 미로염)

1) 이경화증(otosclerosis; 漸聾, 耳漸鳴)

★ 현재의 난청, 이명을 초래할만한 원인이나 선행의 이질환이 없으면서 20세 전후의 젊은 여성에서 많이 발생되어 임신, 수유, 갱년기를 지나면서 악화되는 것으로 Willis 착청을 보이는 질환은? (08,11)

- 골병변으로 미로골포에 새로운 해면상 골성 조직을 형성하여 와우각내의 기존의 골조직과 대치되고 난원창에 침습하여 난원창과 연결되는 등골 족판을 고정시키든지 혹은 와우각에 변성을 일으켜 내이에 전음성 장애를 일으키고 완고한耳鳴과 진행성 難聽을 주로 호소 → 등골과 난원창이 합쳐져 버려서 문제가 생김
- 이경상 외이도가 넓어지고 귀지는 매우 적음. 고막은 정상
- 1) 원인 : 주로 유전적인 관계, 즉 상염색체 우성유전, 약 58%에서 가족력 보임
- 특히 20세 전후의 젊은 여성에서 많이 발생되어 임신, 수유, 갱년기를 지나면서 악화되기에 內分泌 障礙說이 가장 유력
- 2) 증상
- 발병 초기에는 일측성으로 완만하게 진행되는 전음성 難聽과 완고한耳鳴
- 점차적으로 양측성(약 70% 환자) 청력감퇴, 임신기에 가중. 이외에 소음환경에서 소음보다 강한 음이 잘 들리는 Willis 착청 → Willis 착청이 가장 흔한 증상
- 진행함에 따라 감각신경성 難聽 / 眩暈, 惡心, 嘔吐도 발생
- 주로 30세 이전에 難聽

3) 진단 : 공막의 異常發靑과 젊은 여성에서 사춘기 후, 임신 중, 분만 후, 폐경기를 거치면서 악화되면 이경화증을 의심

- 청력검사상 초기에 2kHz에서 20~30dB의 골도청력 소실 보임 (Carhart notch)

→ 앞서 나온 돌발성 난청, 소음성 난청, 노인성 난청 기준 잘 알아두기

- 변증론치

1. 腎精虧虛: 耳聾左慈丸
2. 氣滯血瘀: 通竅活血湯

2) 내이염 및 미로장애

(1) 內耳炎(labyrinthitis) 내이염 : 미로염

- 비유전성 지연성 감각신경성 難聽. 바이러스, 세균, 매독균에 의한 미로의 염증성 병변
- 경로와 특성에 따라 ① 中耳性, ② 腦膜性, ③ 血行性 內耳炎으로 분류

(1) 국한성 內耳炎 : 미로주위염, 미로누공

- 골미로나 골내막에 국한된 감염, 진주종, 육아종에 의한 수평반규관의 팽대부 누공이 원인
- 반복성 현훈과 구토, 구역이 특히 두위 변환으로 악화

(2) 장액성 內耳炎

- 세균의 독소에 의해 발생, 급성 화농성 중이염의 가장 흔한 합병증 중의 하나
- 현훈, 청력은 약간 저하, 중이염에서 자발성 현훈이 있으면 장액성 內耳炎을 의심

(3) 화농성 內耳炎

- 내이에 세균이 침입한 상태. 고실성, 수막성, 혈행성의 3가지중 수막성 원인이 최다
- 증상은 돌발적인 심한 감각신경성 난청, 이명, 현훈 및 안진이 유발되는 것이 특징

(4) 바이러스성 內耳炎

- 홍역, 풍진, 대상포진 바이러스 등이 혈관대를 통하여 내임파액을 침범하여 발생
- 前庭症狀은 수일 내지 수주일 후면 호전되나 난청은 지속되고 회복이 안 됨

(5) 매독성 內耳炎

- 선천성이나 후천성 매독에서 수막과 신경을 통해 迷路炎이 발생
- 돌발성의 감각신경성 난청이 나타나 급히 진행이 되어 심한 양측성 난청이 됨

(6) 뇌수막성 內耳炎

- 수막구균에 의해 발생. 소아 난청의 20%. 고열과 함께 양측에 돌발적 심한 감각신경성 난청, 현훈, 안진 유발. 환자의 10%에서 영구적인 난청이 동반

- 주요증상 : 현훈, 오심, 구토, 균형장애

- 부수증상 : 청각장애

- 변증론치

1. 熱盛動風: 龍膽瀉肝湯合天麻鉤藤飲
2. 肝風內動: 鎮肝熄風湯
3. 肝腎陰虛: 杞菊地黃湯合大定風珠

(2) 내이장애

(1) 여러 가지 질환에 의한 내이장애

- 감염성, 자가면역성, 신경성, 대사성 질환, 신장장애 등이 감각신경성 難聽 발생.

(2) 이독성 약물에 의한 내이장애

- 각종 약물 중독에 의하여 감각신경성 難聽을 유발시키는 것.
- 먼저 高音性 耳鳴이 나타나고 후에 難聽이 나타난다.
- 항생제(Streptomycin, Kanamycin, Gentamicin, Neomycin), 항암제(nitrogen mustard, Cisplatinum), 이노제, Aspirin, quinine, Alcohol, Nicotine 등.
- 치료는 Vitamin B₁, Vitamin A를 병용.
- 이독성으로 인한 難聽은 발생하면 不可逆性, 難治.

(3) 외상성 내이장애

- 파편이나 이물에 의한 외상(등골골절, 內耳瘻孔, 측두골의 종골절 또는 횡골절).

(4) 음향외상성 내이장애

- 소음성 難聽, 직업성 難聽으로 최근에 증가추세. 외유모세포의 감각모 소실, 변성과 세포파괴 발생. 점차 내유모세포침범, 심하면 코르티기의 파괴가 발생

안면신경마비

- 안면신경

1) 주행

- 뇌교 및 연수 경계부에서 기시. 소뇌-교각부에서 전정와우신경 및 중간신경과 합류하여 내이도로 진입. 내이관 안에서 청신경과 갈라져서 안면관을 통하여 슬신경절로 진행. 경유 돌공으로 두개골 밖으로 나와 안면 근육 지배

2) 고색신경 : 혀의 앞쪽 2/3의 미각을 담당. 설하선, 악하선의 분비에도 관여

3) 등골근 지배신경 : 청각과민

4) 대추체신경 : 누선 지배

가. 벨마비

- 원인 : Virus 감염, 외상, 가족성 소인, 중이염의 후유증, 뇌종양, 당뇨 라임병, Guillain Barre syndrome 등. 알리지설, 바이러스설, 염증설, 혈관경련에 의한 혈액순환장애 등의 여러 학설

- 증상 : 이후통이 있는 후 1~2일지나 안면마비 발생. 48시간 내에 가장 심해짐. 수주~수개월 내에 80% 이상 회복. 특징적인 바이러스 전구증(60%), 설인신경, 삼차신경의 감각감퇴, 이상감각(80%), 안면부 혹은 경부의 이상감각(안면저림)과 동통(60%), 미각장애(57%), 청각과민(30%), 눈물감소(17%), 유루증, 이명 등

나. 외상성 안면신경마비

- 의인성과 비의인성
- 측두골내 손상과 측두골외 손상
- 뇌진탕, 중추신경 외상, 관통상, 안면열상 등

다. 감염성 안면신경마비

- 바이러스성
- 세균성

라. 종양성 안면신경마비

마. 기타질환에 의한 안면신경마비

- Melkersson-Rosenthal증후군 : 재발성 구강안면부종, 재발성 안면신경마비, 균열설의 3대 특징

→ 외상성, 감염성, 종양성, Ramsay-Hunt 이렇게 4가지는 예후가 안 좋음

★ 중추성과 말초성의 감별 ★

	중추성	말초성
장애부위	반대측	동측
이마주름	O	X
눈감기	O(Δ)	X
上視	X	O
휘파람	X	X

→ 가장 중요한 감별 포인트는 이마주름

장애부위에 따른 말초성 안면신경마비의 감별

부위	안면마비 이외의 증상	원인
뇌교	외전신경마비(안면마비와 동측) 반대측의 편마비	혈관장애, 종양 다발성 경화증
소뇌교각	난청, 이명, 현기증 각막반사 소실, 소뇌증상	소뇌교각종양, 청신경종양 수막종
슬상신경절 이상 측두골내	청신경 장애시 청력장애, 혹은 청각과민, 눈물과 타액분비의 감소, 혀의 전방 2/3의 미각장애	외상, 종양, 염증(중이에서 파급) 대상포진(Ramsay- Hunt증후군)
고색신경 이상 슬상신경절까지	혀의 전방 2/3의 미각소실 , 누액분비장애, 청각과민	염증, 외상, 중이염 다발성 신경염
고색신경 분지부에서 말초	안면마비 외에는 없음	Bell's palsy, 다발성 신경염 염증, 외상
경유돌공에서 말초	안면마비 외에는 없음(부분적)	외상, 염증, 이하선 종양

- 평가방법 및 검사

1) House-Brackmann 검사법 : I 등급은 정상 상태이며, VI등급은 안면 운동기능이 완전히 없는 상태. I,II등급은 만족할 만한 단계이며, III,IV등급은 불만족스러운 단계이다. IV,V등급은 마비된 측의 눈썹을 올릴 수 없거나 심각한 동조 운동이 있는 경우

2) 안면신경검사

① 누액분비검사(Shirmer's test)

② 등골반사검사 : 임피던스청력검사의 등골반사검사로 이를 확인

③ 타액분비검사 : 악하선관에 삽관을 시행

- 변증론치

1) 風邪外襲 : 牽正散加味

2) 虛風內動 : 四物湯合牽正散

3) 氣血瘀阻 : 當歸補血湯合桃紅四物湯

야나기하라 안면신경마비 평가

	완전마비	중간			정상
안정 시 안면 비대칭	0	1	2	3	4
이마에 주름잡기	0	1	2	3	4
가벼운 눈 감기	0	1	2	3	4
강하게 눈 감기	0	1	2	3	4
눈 깜박이기	0	1	2	3	4
코 주름 만들기	0	1	2	3	4
환측 눈만 감기 (윙크)	0	1	2	3	4
'이~'하고 치아 보이기	0	1	2	3	4
'오~'하고 휘파람 불기	0	1	2	3	4
'으~'하며 아랫입술 내리기	0	1	2	3	4

→ 임상에서는 야나기하라법으로 차등함